识别时间、表现与高危人群

眼内注药后非感染性眼内炎症 · 2025 专家共识

适用范围

玻璃体腔、视网膜下、脉络膜上腔注药后继发 SIOI；目标使用者为开展注药的眼底病专科医师。

2025 刊 p493 、 495 / PDF2 、 4

推荐一：发生时间

多数 SIOI 在末次注药 10 d 内；高剂量抗 VEGF 呈双峰，第一峰末次注药 1 周内，第二峰首次注药约 4 周。各药研究发生率为不同样本结果，不能互当预测概率。

2025 刊 p496–497 / PDF5–6 · 强推荐

推荐二：表现

常为轻中度前 / 后节炎症、视模糊 / 飞蚊 / 轻痛；万古霉素和高剂量抗 VEGF 可引发 RV/RO ，多发暗点、黄斑受累可重损视力。

2025 刊 p497–498 / PDF6–7 · 强推荐

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

预防、储运与固定监测

眼内注药后非感染性眼内炎症 · 2025 专家共识

推荐三：高危因素

药物、操作与个体因素共同作用；女性、自身免疫病或葡萄膜炎史、促炎药物使用者重点关注。无正式预测分数。

2025 刊 p499 / PDF8 · 中等推荐

推荐四：预防

规范储运，优选无硅油 / 预充注射器与低免疫原性药物；不常规预防 ST-TA ，高危 / 既往 SIOI 可酌情；高危者避免双眼同期注药。

2025 刊 p499 / PDF8 · 中等推荐

储运与操作

原文生物制剂 2 ～ 8 ℃ 避光储运，开封后 8 h 内完成注射；避免弹 / 剧烈摇注射器。具体药品要求需另核说明书，不将 8 h 当所有产品通则。

2025 刊 p498 / PDF7

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

就诊、鉴别与寻找血管病变

眼内注药后非感染性眼内炎症 · 2025 专家共识

推荐五：监测体系

宣教、知情、随访、诊断四环节；高危人群重点说明 SIOI 表现，专项沟通通道，按药物特性个体化随访。

2025 刊 p500 / PDF9 · 强推荐

固定随访与症状

注药后第 1 天、第 1 周、第 4 周；持续 2 d 以上不适 / 飞蚊加重及时就诊；明显视力下降或畏光立即就诊。图 1 写 >2 d，保留正文 / 图示差异。

2025 刊 p500–501 / PDF9–10

诊断先鉴别

排除感染性眼内炎、葡萄膜炎首发 / 复发、潜伏病原激活、陈旧积血、 TA 假性积脓及肿瘤伪装等；视力、眼压、裂隙灯和散瞳眼底。

2025 刊 p500 / PDF9

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

影像与阶梯治疗

眼内注药后非感染性眼内炎症 · 2025 专家共识

推荐六：寻找 RV/RO

确诊并鉴别后系统排查 RV/RO；引导眼位超广角照相、超广角 FFA 评估周边灌注；所有确诊者强化随访至炎症静止。

2025 刊 p500 / PDF9 · 强推荐

影像替代与不可视

FFA 禁忌 / 拒绝可用超广角 OCTA+ 引导眼位；有条件 ICGA 看脉络膜。玻璃体严重混浊，每次 B 超至眼底可视；后续重复寻找延迟 RV/RO 。

2025 刊 p500 / PDF9

轻度与前节强化

轻度前房 / 玻璃体炎可局部 NSAID 或激素；前节较重可激素每小时 1 次。充分激素后不缓解或加重 → 重新鉴别感染，再决定升级。

2025 刊 p501 / PDF10

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

原文剂量：局部及 RV

眼内注药后非感染性眼内炎症 · 2025 专家共识

表 4： 无 RV/RO 局部剂量

滴眼 4 次 /d 至 1 次 /h； TA 结膜下 4 ～ 8 mg 、球旁 20 ～ 40 mg 、球内 1 ～ 2 mg 。球内 TA 标为超说明书用药，非无条件常规方案。

2025 刊 p502 / PDF11

表 4： RV 剂量

TA 球旁 20 ～ 40 mg ；球内 TA 1 ～ 2 mg 或地塞米松植入剂；口服泼尼松龙 0.5 ～ 1.0 mg/ （ kg · d ）；甲泼尼龙静滴 500 mg 、 1 次 /d 。球内 TA 超说明书。

2025 刊 p502 / PDF11

药物疗程缺项

表 4 剂量须按个体严重程度升级；统一疗程、递减方式、植入剂剂量、全部免疫调节剂方案和肝肾调整：原文未明确，不能补编。

2025 刊 p502 / PDF11

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

RO 、再注药与特殊 HOCRV

眼内注药后非感染性眼内炎症 · 2025 专家共识

表 4： RO 剂量

TA 球旁 20 ～ 40 mg ；球内 TA 1 ～ 4 mg 或地塞米松植入剂；口服泼尼松龙 1.0 mg/ （ kg · d ）；甲泼尼龙静滴 500 ～ 750 mg 、 1 次 /d 。球内 TA 超说明书。

2025 刊 p502 / PDF11

活动期与再注药

炎症活动期严格避免再次用相同 / 同类药；继续基础抗 VEGF 需待炎症消退或预计眼内药已清除。 TA 相关后节 SIOI 避免再行 TA 玻璃体腔注射。

2025 刊 p502 / PDF11

HOCRV 特殊处理

万古霉素 HOCRV 视网膜缺血更重，强化抗炎并尽早抗 VEGF ，广泛缺血可 PRP ； 避免高剂量抗 VEGF 及基因治疗。此为特殊段落，勿套成普通 SIOI 早期常规激光。

2025 刊 p502 / PDF11

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

升级、推荐强度与预后

眼内注药后非感染性眼内炎症 · 2025 专家共识

推荐七：阶梯治疗

以激素为核心，按部位、严重度、 RV/RO 选择 / 升级；每次散瞳与定期 FFA 。玻切为混浊 / 残药可有理论获益；激光仅用于炎症消退后的广泛无灌注 / 新生血管。

2025 刊 p502 / PDF11 · 中等推荐

RV/RO 升级

RV 先排 RO ；较广 / 重可全身激素，顽固考虑植入剂 / 免疫调节。 RO 更积极抗炎，广泛 / 累及黄斑可联合降压 / 血管扩张，定期 FFA 。

2025 刊 p501–502 / PDF10–11

推荐八：预后

多数非万古霉素 SIOI 轻且短；合并 RV/RO 时预后取决于黄斑受累、缺血程度和 RO 可逆性，及时积极激素为核心。

2025 刊 p503 / PDF12 · 中等推荐

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

一页流程｜眼内注药后非感染性眼内炎症

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2025

1 注药后动态监测

第 1 天 /1 周 /4 周；显著视降或畏光 → 立即就诊；持续 2 d 以上不适 / 飞蚊 → 及时就诊。

2025 刊 p500–501

2 是否已排除感染及伪装?

否 / 不确定 → 完成鉴别，不能直接按无菌炎症处理；完成 → 系统查 RV/RO 。

2025 刊 p500

3 影像及分支

照相 +FFA 看灌注； FFA 禁忌可 OCTA ，混浊 B 超。无 RV/RO 、 RV 、 RO 三分支按部位 / 严重度用药。

2025 刊 p500 、 502

4 阶梯治疗及疗效判断

激素充分治疗不缓解 / 加重 → 重新排感染； RV/RO → 更积极抗炎、定期 FFA 、按需升级。

2025 刊 p501–502

5 炎症静止与基础病

活动期避免相同 / 同类再注；普通 SIOI 激光仅静止后广泛无灌注 / 新生血管， HOCRV 另评估。

2025 刊 p502

6 随访至完全静止

所有确诊者缩短复诊，重复查延迟 RV/RO ；黄斑缺血影响预后，统一增频间隔 / 疗程未明确。

2025 刊 p500 、 502–503

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。